

Bilan annuel de synthèse - ESMS

EHPAD • FAM • MAS • adulte | Socle raisonné, sans biologie inutile

Point clé

- Il n'existe pas de panel biologique annuel légalement obligatoire pour tous les résidents d'ESMS.
- Le bilan annuel est une proposition de qualité des soins, à individualiser selon l'âge, la fragilité, les pathologies et les traitements.
- Chez l'enfant/adolescent en IME : ne pas appliquer automatiquement le socle adulte.

Socle annuel proposé - adulte / personne âgée fragile

- NFS-plaquettes
- Na, K, créatinine + DFG CKD-EPI (urée si déshydratation/MRC)
- Albuminémie si risque nutritionnel; CRP seulement si contexte inflammatoire ou pour interpréter une albumine basse
- Glycémie à jeun ou HbA1c si diabète, prédiabète, corticothérapie, antipsychotique ou risque métabolique

À ajouter seulement si indication

- ASAT/ALAT ± GGT/PAL/bilirubine : hépatopathie, risque hépatique, médicament hépatotoxique ou anomalie antérieure.
- EAL : stratégie CV active, diabète/MRC, statine ou anomalie antérieure; pas nécessairement annuel chez tous.
- TSH : dysthyroïdie, lévothyroxine, lithium, amiodarone ou symptômes.
- Ferritine + CST : anémie, MRC, suspicion de carence; B12/folates : macrocytose, neuropathie ou contexte à risque.

Antiépileptiques - ne pas automatiser les dosages

- Valproate, carbamazépine, phénobarbital : dosage plasmatique seulement si indication clinique/pharmacologique.
- Pas de dosage annuel systématique chez un patient stable.
- Si dosage : préciser heure de dernière prise, posologie et galénique.

25-OH vitamine D - remboursement

- Pas de dosage de routine.
- Remboursement limité aux 6 indications NABM : rachitisme/ostéomalacie suspectés; transplanté rénal adulte >3 mois; avant/après chirurgie bariatrique; personne âgée avec chutes répétées; RCP préconisant le dosage.
- Hors cadre : mention "NR".
- Ostéoporose isolée ou chimiothérapie seules ne suffisent pas.